

Centro de atención : Centro Médico Escuela Militar

Nombre : AHMAD -, RANA WASEEM
Rut-pasaporte:22043974-7
F.Nacimiento: 19-ene-1964
Fecha Atención: 27-may-2026

N° Episodio: 1025361110
Procedencia:

TAC DE TORAX

Antecedentes Clínicos:

ICC. Enfermedad renal crónica. Status post cirugía de by-pass coronario y reemplazo de aorta ascendente y reparación endovascular de aneurisma de aorta abdominal.

Hallazgos:

Leve derrame pleural hipodenso bilateral, algo mayor a derecha, asociados a atelectasias pasivas subsegmentarias pulmonares bibasales.

Engrosamiento septal interlobulillar liso pulmonar bilateral de predominio hacia las bases, de aspecto congestivo, con tenues y escasas opacidades con densidad de vidrio esmerilado que sugieren escaso componente alveolar. Algunas bandas atelectásicas subsegmentarias en ambos lóbulos superiores. No se observan focos de condensación en el parénquima pulmonar. No se observan masas ni nódulos de aspecto patológico en el parénquima pulmonar.

En fase espiratoria no se observa atrapamiento aéreo significativo.

No hay neumotórax.

Tráquea y bronquios principales permeables, sin visualizar lesiones endobronquiales obstructivas.

Cardiomegalia con dilatación de atrio izquierdo. Acentuada ateromatosis cálcica coronaria.

Cambios post quirúrgicos de cirugía de revascularización miocárdica y recambio protésico de aorta torácica ascendente. No se observan colecciones mediastínicas. Acentuada ateromatosis cálcica aórtica. Tronco de arteria pulmonar aumentado de calibre, alcanzando 39 mm de diámetro.

No hay derrame pericárdico.

No hay dilatación esofágica.

No se observan adenopatías mediastínicas, solo linfonodos de caracteres morfológicos normales.

No se observan adenopatías hiliares ni axilares.

Lesión de estirpe lipomatosa subcutánea profunda de región dorsal paramediana derecha que mide 5,3 cm, sin componentes de densidad de partes blandas.

Esclerosis de cuerpos vertebrales, que en este contexto hace sospechar osteodistrofia renal.

Impresión:

Signos de edema pulmonar intersticial y con escaso componente alveolar. Leve derrame pleural hipodenso bilateral.

Cardiomegalia con dilatación de cámaras cardíacas izquierdas. Acentuada ateromatosis cálcica aortocoronaria. Cambios post quirúrgicos de cirugía de revascularización miocárdica y reemplazo protésico de aorta ascendente. No se demostraron colecciones mediastínicas. Aumento del diámetro del tronco de arteria pulmonar que puede estar en contexto de hipertensión pulmonar.

Atentamente,

Dr. Joaquin Hevia Morel

Informe Validado por: **Dr. Joaquin Hevia Morel**

Paciente: AHMAD -, RANA WASEEM